

	Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo IVa	Tipo IVb	Tipo IVc	Tipo IVd
Reactor inmune	IgE	IgG, IgM	IgG (complejos inmunes circulantes)	TH1, INF γ , TNF α	TH2, IL4, IL5, IL13	Linfocitos citotóxicos, perforinas/granzimas	LT, CXCL8, GM-CSF
Patogenia	Mediada por IgE; reacciones inmunitarias de tipo inmediato	El fármaco + anticuerpos citotóxicos causan lisis de células como las plaquetas o leucocitos	Anticuerpos IgG o IgM formados contra el fármaco; se depositan complejos inmunitarios en pequeños vasos, lo que activa el complemento y atracción de granulocitos	Reacción inmunitaria mediada por células; los linfocitos sensibilizados reaccionan con el fármaco, liberando citocinas, que activan la respuesta inflamatoria cutánea. Sensibilidad por contacto Respuestas inmunes mediadas por linfocitos TH1	Respuestas inmunes mediadas por linfocitos TH2	Respuestas inmunes mediadas por linfocitos T	Respuestas inmunes mediadas por neutrófilos
Manifestaciones clínicas	Broncoespasmo Estornudos Rinorrea Congestión nasal Urticaria Angioedema Cólicos abdominales Diarrea Hipotensión Shock anafiláctico	Anemia hemolítica Neutropenia Plaquetopenia	Artritis Serositis Nefritis Vasculitis	Fibrosis Reacción de injerto contra el huésped			

	(casos más graves)						
Enfermedades	Rinitis Asma	Citopenias autoinmunes Enfermedades autoinmunes órga-no-específicas Fiebre reumática Citopenias por fármacos	Lupus eritematoso sistémico	Artritis reumatoide Dermatitis de contacto	Asma Rinitis alérgicas Dermatitis atópica Exantemas maculopapulares por fármacos	Necrolisis epidérmica tóxica por fármacos	Pustulosis exantemáticas agudas (inducida por fármacos) Enfermedad de Behçet
Fármacos causantes	Penicilina: Metabolito peniciloil, unido a una proteína plasmática (conjugado hapteno-carrier), es capaz de inducir síntesis de IgE	Penicilina Sulfonamidas Quinidina Isoniazida Cefaclor Cefalexina Trimetropim-sulfametoxazol Amoxicilina AINES Diuréticos	Inmunoglobulinas Antibióticos Rituximab Infliximab	Antibiótico Anticonvulsivos Alopurinol			

Referencias

Konstantinov N.K., & Bigliardi P.L. (2023). Reacciones cutáneas adversas a fármacos. Soutor C, & Hordinsky M.K.(Eds.), Dermatología clínica: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades comunes, 2e. McGraw Hill.
<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3375§ionid=282015006-Hill>.

Salazar de Plaza, Esmeralda, & Pimentel Herrezuelo, Eva. (2002). Reacciones alérgicas a los Fármacos. Acta Odontológica Venezolana, 40(1), 72-73. Recuperado en 14 de noviembre de 2023, de
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-63652002000100017&lng=es&tIng=es.

Salinas, L.J. (2012). Mecanismos de daño inmunológico. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-mecanismos-dano-inmunologico-S071686401270336X>